**Autos: 0801530-29.2024.8.12.0010**
**Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
**Autor:Katia Laura de Souza**
**Réu: Estado de Mato Grosso do Sul**

SENTENÇA

**Katia Laura de Souza** promove ***"Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência"*** em face do **Estado de Mato Grosso do Sul**, ambos qualificados na inicial (p. 1).

Em síntese, a parte autora argumentou que é portadora de gonartrose (CID M17) e transtorno de rótula (CID M22) e em razão das enfermidades, necessita do procedimento de viscosuplementação com a utilização dos medicamentos ácido hialurônico (Opus Joint) e Trianccinolona (Triancil), com indicação médica de infiltração de ácido hialurônico e corticosteróide intra-articular para manejo da dor e da inflamação, mas tal tratamento não é disponibilizado pelo SUS, bem como não possui condições financeiras para custear o gasto com o tratamento.

Com base nesses fatos, formulou pedido para concessão antecipada da tutela de urgência, com ordem para que o Estado de Mato Grosso do Sul cumpra imediatamente com a obrigação de fornecer o tratamento/medicamentos receitados, sob pena de multa. O pedido final consiste na confirmação da tutela de urgência. Requereu, também, o benefício da gratuidade. Deu à causa o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

A petição inicial (p. 1/8) veio acompanhada de declaração de pobreza (p. 9) e documentos (p. 10/21).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável aos pedidos (p. 25/35; p. 39/40).

Na decisão de p. 41/43, o juízo concedeu assistência judiciária gratuita à autora e indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Em contestação (p. 50/56), o Estado de Mato Grosso do Sul aduziu a necessidade de observância do TEMA 1234 e TEMA 6, ambos do STF. Discorreu sobre os requisitos específicos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e sobre a recomendação da CONITEC para a não incorporação do medicamento Hilano GF-20 (Ácido Hialurônico). Aduziu a ausência de pedido administrativo, a necessidade de observância do PMVG da CMED e a inviabilidade de fornecimento da medicação com base no nome comercial. Diante do exposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. No caso de procedência, requer: a. seja estipulada a obrigatoriedade da apresentação de receita médica atualizada para retirada dos medicamentos e que seja autorizado o forneci- mento com base no princípio ativo, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.787/99. b. no caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o seu arbitramento seja feito pelo critério da equidade (art. 85, § 8º, CPC). c. no caso de execução forçada do julgado, não haja fixação de multa diária, dando-se preferência ao bloqueio de verbas, nos termos do enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde. d. em caso de bloqueio de valores para



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

aquisição do medicamento, seja ob- servado o PMVG.

A parte autora impugnou a contestação (p. 58/74).

**É o relatório.**
**Fundamento e decido.**

O feito comporta julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nossos Tribunais assim têm se pronunciado a respeito do julgamento antecipado: "*Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder*". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: "*O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art.130). Se o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia*" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475).

***Mérito:***

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte requerente aduz que é portadora de gonartrose (CID M17) e transtorno de rótula (CID M22) e em razão das enfermidades, necessita do procedimento de viscosuplementação com a utilização dos medicamentos ácido hialurônico (Opus Joint) e Trianccinolona (Triancil), com indicação médica de infiltração de ácido hialurônico e corticosteróide intra-articular para manejo da dor e da inflamação, mas tal tratamento não é disponibilizado pelo SUS, bem como não possui condições financeiras para custear o gasto com o tratamento.

O pedido esboçado pela parte autora **não merece acolhimento**.

A apreciação do pedido de disponibilização de medicamentos exige cautela, sob pena de imputar consequências irremediáveis ao jurisdicionado e/ou interferir na esfera de competência do Executivo, porquanto, em sendo a saúde um dever, cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos, em especial àqueles sem recursos econômicos, o acesso universal e igualitário à assistência médica e farmacêutica.

Inicialmente, anoto que, para concessão de fármacos não disponibilizados pela rede pública de saúde, tampouco padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), devem ser integralmente preenchidos os requisitos exigidos nos TEMAS 1234 e 6 do STF, além do TEMA 106 do STJ.

Infere-se que houve a negativa administrativa quanto ao fornecimento dos medicamentos (p. 16/17), bem como que a receita médica faz menção aos medicamentos pelo nome comercial e foi elaborada por médico particular (p. 11/12).



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

Quanto à hipossuficiência econômica da parte autora, tem-se que devidamente demonstrada, pois está sendo assistida pela DPE, de modo que presume-se a hipossuficiência consubstanciado na declaração de p. 9, sobretudo porquanto o requerido não apresentou documentos capazes de afastar a presunção.

Os medicamentos solicitados pela requerente estão devidamente registrados na ANVISA (p. 32, item IV).

Contudo, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável ao pleito (p. 33/33, item XI), que:

> **XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.**
>
> Considerando que a paciente está sendo atendida por médico particular.
>
> Considerando que Ácido Hialurônico, Hexacetonido de Triancinolona não estão padronizados na RENAME 2022.
>
> Considerando o PCDT da Dor Crônica, Portaria SAS/MS nº 1083 de 02/11/2012, que oferece os medicamentos Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido Valproico, Codeína, Morfina, Metadona, sendo que a paciente não está cadastrada.
>
> Considerando que a RENAME 2022 tem padronizado no CBAF medicamentos analgésicos (Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol), anti-inflamatório (Ibuprofeno), corticoides (Dexametasona, Prednisona, Prednisolona, Ésteres de Betametasona), antidepressivos (Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fluoxetina), antiepiléticos (Ácido Valproico, Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina), além de fisioterapia e consultas com nutricionista e educador físico.
>
> Considerando as evidências científicas disponíveis, a recomendação da CONITEC pela não incorporação do Hilano GF-20, as ausências de informações sobre tratamentos realizados e de exames complementares, as opções de tratamentos/medicamentos oferecidos pelo SUS.
>
> Em razão do exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Hialuronato Sódico, Hexacetonido de Triancinolona.

A seu turno, quanto à *imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS*, observa-se que o laudo médico carreado aos autos (p. 11; p. 13/15) limita-se a apontar as doenças diagnosticadas na parte requerente e a necessidade dos medicamentos receitados, porém não existe um detalhamento técnico do porquê não ser possível a utilização dos medicamentos padronizados na RENAME.

Diante disso, caberia à parte requerente demonstrar o preenchimento do requisito relativo à imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, nos termos do decidido no mencionado recurso julgado sob o rito repetitivo. Todavia, apesar dos documentos médicos amealhados com a exordial prescreverem os medicamentos (p. 12), devidamente registrados na ANVISA, tem-se que não restou comprovada sua indispensabilidade e a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Aliás, no tocante aos medicamentos postulados na inicial, conforme parecer do NAT (p. 33, item VII):



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

**VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;**

O Ácido Hialurônico, Hexacetonido de Triancinolona não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) ou outro ato normativo do SUS.

A CONITEC analisou o Hilano GF-20, um derivado do Ácido Hialurônico (ou Hialuronato de Sódio), conforme Relatório de recomendação nº 132 – Hilano GF-20 para o uso intra-articular no tratamento de dor associada com a osteoartrose do joelho (CONITEC, dezembro/2014).

A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança da visco-suplementação, em especial do hilano G-F 20, SYNVISC, ácido hialurônico de alto peso molecular, para o tratamento da osteoartrite do joelho, é baseada em tipos de estudos com nível de evidência A, com ressalvas. A partir da evidência analisada, o benefício do hilano G-F 20 é controverso, principalmente em relação às atuais opções de tratamento disponíveis no SUS. Em curto prazo, o ácido hialurônico parece ser tão eficaz quanto, mas não mais eficaz do que os anti-inflamatórios não esteroidais, em relação aos desfechos subjetivos: dor e função articular. O ácido hialurônico também se mostrou tão eficaz quanto, mas não mais eficaz do que os corticosteroides intra-articulares para aliviar a dor noturna e a dor ao repouso. O produto, desde 2009, está registrado na ANVISA como produto para a saúde, não como medicamento, por ser produto inerte e que não interfere nos processos intra-articulares. No entanto, a infiltração articular tem risco inerente ao procedimento, podendo levar a sérias infecções se não forem observados os preceitos de higiene e antissepsia.

Devido à fragilidade dos dados apresentados acerca das evidências atualmente disponíveis sobre o tema, ao custo elevado e à alta prevalência da doença, o que geraria um impacto orçamentário muito elevado, os membros da CONITEC, presentes na 25ª reunião do plenário realizada nos dias 07 e 08/05/2014, decidiram, por unanimidade, **não** recomendar a incorporação do Hilano G-F 20 para o uso intra-articular no tratamento de dor associada com a osteoartrose do joelho.

Verifica-se, assim, que há evidencias científicas pela não incorporação do medicamento Hilano G-F 20 para os fins pretendidos pela parte autora (p. 30/31, item VII).

Ademais, a negativa de fornecimento do medicamento está de acordo com os protocolos estabelecidos pelo SUS, sendo decisão técnica e administrativa devidamente fundamentada, não cabendo ao Judiciário sobrepor sua decisão às políticas públicas vigentes, a menos que haja flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado.

Nesse trilhar, considerando que os medicamentos postulados não estão incorporados pelo SUS, e não havendo qualquer indicativo de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação, não há falar em obrigação do poder público em fornecer esses medicamentos.

Além disso, considerando a ausência de comprovação quanto à essencialidade dos medicamentos prescritos para tratamento da parte autora e quanto ao esgotamento de todas as alternativas medicamentosas oferecidas pelo SUS, as quais podem se mostrar eficazes na contenção das doenças, entendo não ser prudente conceder, no presente momento, a medicação receitada pelo profissional de saúde.

Apesar de o profissional médico indicar, como regra, o melhor tratamento que aprouver ao paciente, utilizando-se de todos os meios ao seu alcance para efetivar o direito à saúde, no caso concreto o médico responsável pelo atendimento da autora deixou de fundamentar os motivos pelos quais prescreveu medicamentos



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

diferentes dos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, deixando de consignar o porquê resta impossibilitada a utilização das demais alternativas fornecidas pelo SUS.

Não obstante o direito à saúde, o tratamento a ser disponibilizado não deve ficar ao livre arbítrio do paciente ou de determinado profissional da área médica, sem que se demonstre que o medicamento pretendido é o único ou o mais apto para a finalidade indicada, especialmente quando o ente público disponibiliza opção terapêutica que alega satisfatória.

Inclusive, em momento algum constou do laudo médico que as substâncias receitadas pelo NAT como passíveis de controlar as doenças e ainda não utilizadas pela parte autora são impróprias, inadequadas ou não produzem os efeitos adequados ao tratamento da patologia.

Destarte, não existe qualquer elemento seguro para afirmar que todos os medicamentos indicados foram utilizados pela parte requerente sem a eficácia no tratamento de maneira que possa subsidiar o acolhimento do pedido inicial.

Sobre o tema, o Enunciado n. 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiçam, realizada em 15 de maio de 2014 – São Paulo/SP, preconiza que *"nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS"*, o que, frise-se, não foi feito no caso em testilha.

Nesse sentido, o direito à saúde, que foi definido pela Constituição da República como um direito fundamental da pessoa humana, deve ser levado à sério, tanto pelo Estado quanto pelos profissionais que atuam no sistema de saúde pública ou privada, cuja atuação deve ser pautada pela medicina baseada em evidências e não mais na medicina baseada na autoridade

Não se pode olvidar, ainda, que demonstrando a autora a necessidade do remédio (fato constitutivo de seu direito) e o réu, a possibilidade de sua substituição por outros (fato modificativo/impeditivo), incumbe à primeira a demonstração da impossibilidade da substituição, o que não ocorreu.

Quanto à idoneidade do posicionamento do NAT, é sabido que tal núcleo de apoio foi criado com a finalidade assessorar o Poder Judiciário Estadual, contribuindo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo órgão de natureza consultiva.

Portanto, sua função é conferir ao julgador maiores elementos técnicos necessários ao desfecho das lides, sem que o magistrado esteja vinculado aos seus pareceres, os quais são isentos de qualquer parcialidade.

Seguindo tal linha intelectiva, somente devem ser afastadas as orientações do NAT em situações em que resta demonstrada a imprescindibilidade justificada para a utilização de medicamentos diversos do protocolo clínico estabelecido



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diversamente do que ocorreu no caso em tela.

Nesse aspecto, percebendo-se do conjunto dos autos que os medicamentos objetos do pedido não são de natureza essencial ao caso da parte requerente, tal fato recomenda a manutenção da conclusão negativa do parecer confeccionado pelo NAT.

A respaldar o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, é necessária a demonstração de que os fármacos fornecidos pelo Poder Público não foram eficazes para o tratamento, tem-se os seguintes julgados:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA. –* ***RESP. N.º 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS****. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa, sem que configure cerceamento de defesa. De acordo com a tese fixada no REsp n. 1.657159, "****A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Ausente comprovação da imprescindibilidade da medicação reclamada e da ausência de ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS.****
> *(****TJMS****. Apelação Cível n. 0803514-50.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 29/03/2021, p: 06/04/2021)*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE URGÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –* ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMAS 106, DO STJ E 1234, DO STF – LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO E DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS FÁRMACOS – LAUDO MÉDICO DESACOMPANHADO DE RESPALDO CIENTÍFICO DE ALTO NÍVEL – SENTENÇA REFORMADA*** *– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil dada por esta Câmara e tendo em vista o princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, do CPC, ressalvado o posicionamento deste julgador. Segundo o tema repetitivo n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

*paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Contudo, após a interposição do recurso de apelação pelo ente municipal (29/02/2024), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024, proferiu o julgamento do tema 1234, fixando os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado: "[...] 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...]" **Na hipótese dos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida que os estudos apresentados pelo NAT não evidenciam a eficácia dos medicamentos postulados e a inexistência de substituto terapêutico.** Além do mais, sequer foi acostado aos autos a negativa do fornecimento da Administração Pública, o que impede a análise de eventual ilegalidade do ato administrativo.*
*(**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0802876-89.2023.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Alexandre Corrêa Leite, j: 31/01/2025, p: 03/02/2025)*

Portanto, o papel do Poder Judiciário, em casos como o presente que buscam o fornecimento de medicamento pelo Poder Público não pode se desviar das diretrizes e da Política Pública de Medicamentos, sob pena de usurpar a competência do Poder Executivo e prejudicar não só a saúde da própria parte requerente, através da concessão do medicamento pedido segundo entendimento deste ou daquele médico, desconsiderando a existência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estão baseados em evidências científicas, mas também todo o Sistema Público de Saúde que depende da regulação estatal para manter a atenção básica e avançada de saúde em todas as suas frentes.

Na hipótese, portanto, diante da ausência de demonstração nos autos de que a parte autora tenha feito uso de todos os fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS e que este tenham sido ineficazes, inexistindo justificativa médica plausível para a utilização do tratamento pleiteado, em vez do fornecido pelo SUS, não comporta acolhimento o pedido.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.

**Dispositivo:**

Posto isso, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **improcedente** o pedido, tornando-se definitiva a decisão de p. 41/43 que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Condena-se a parte requerente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, haja vista o zelo profissional, os atos processuais realizados, a natureza da demanda e o tempo na prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte devida pela requerente, vez que goza dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Intime-se o Estado e a DPE pelo SAJ, dando-se-lhes vista dos autos.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo modificação da presente decisão, arquivem-se os autos, com baixa.

Às providências.

Fátima do Sul, data da assinatura digital.

Vitor Dias Zampieri
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VITOR DIAS ZAMPIERI, liberado nos autos em 01/04/2025 às 16:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801530-29.2024.8.12.0010 e código weExihcT.